GymnasiumWildeshausen

Mattis Becker

Cannabiskonsum - Welche neurobiologischen, psychischen und sozialen Folgen kann er im Jugendalter haben?

Erstellt im Rahmen des Seminarfachs:

Sport und Gesundheit

Schuljahr 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung ... 2
Themenhinführung ... 2
Problemstellung ... 2
Ziel der Arbeit ... 2
2. Theoretischer Hintergrund ... 2
2.1 Definition von Cannabis und Wirkstoffen ... 2
Botanik und Grundstoffe ... 2
Neurobiologische Wirkweise im Körper ... 3
2.2 Entwicklungspsychologischer Rahmen ... 6
Gehirnentwicklung ... 6
3. Kurzfristige Folgen des Konsums im jungen Alter ... 6
3.1 Kognitive und motorische Effekte ... 6
3.2 Psychische Effekte ... 7
3.3 Soziale Auswirkungen ... 8
4. Langfristige Folgen des Konsums im jungen Alter ... 9
4.1 Neurobiologische Entwicklung ... 9
4.2 Psychische Effekte und langfristige Gesundheit ... 9
4.3 Suchtentwicklung ... 10
4.4 Soziale Auswirkungen ... 10
5. Erfahrungsberichte ... 11
5.1 Durchführung ... 11
5.2 Ergebnisse ... 11
5.2.1 Konsumverlauf und -muster ... 11
5.2.2 Schulische Entwicklung ... 12
5.2.3 Psychische Gesundheit ... 12
5.2.4 Soziales Verhalten und Beziehungen ... 12
5.2.5 Körperliche Gesundheit ... 13
5.2.6 Kontrollverlust und Abhängigkeit ... 13
5.2.7 Rückblickende Einschätzung und Reflektion ... 13
6. Fazit ... 14
7. Literaturverzeichnis ... 15

1. Einleitung

Themenhinführung

Am 1. April 2024 trat in Deutschland das Cannabisgesetz (kurz CanG) in Kraft. Dieses Gesetz legalisierte sowohl den Konsum, als auch den privaten Besitz von Cannabis. Des Weiteren ist seitdem auch der Eigenanbau für den Eigenkonsum von bis zu drei Cannabispflanzen möglich[1].

Problemstellung

Dieses Gesetz sorgte für eine ausführliche politische Debatte, bei der vor allem der Jugendschutz im Vordergrund stand. Kritiker des Gesetzes befürchteten, dass die Legalisierung von Cannabis dem Jugendschutz schaden würde. In ihrem Fokus stand mitunter, dass bei Jugendlichen besonders die kognitiven Fähigkeiten unter dem Konsum von Cannabis leiden würden, doch wie wirkt sich Cannabis eigentlich auf biologischer Ebene auf den menschlichen Körper aus?

Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Facharbeit wird deswegen sein, darzustellen, welche neurobiologischen Wirkmechanismen Cannabis auslöst und auf dieser Grundlage die kurz- und langfristigen Folgen des Konsums von Cannabis im Jugendalter zu analysieren. Dabei soll vor allem im Vordergrund stehen, wie der frühe Konsum in der Jugendphase mit kognitiven, psychischen und sozialen Risiken verbunden ist. Ergänzend werden individuelle Erfahrungsberichte herangezogen, um die Befunde der Studien kritisch einordnen zu können.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Definition von Cannabis und Wirkstoffen

Botanik und Grundstoffe

Der Name *Cannabis* wurde das erste Mal im Jahr 1753 vom schwedischen Naturforscher Carl von Linné verwendet, als dieser anfing eine einheitliche

[1] Bundesgesetzblatt Teil I - Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften - Bundesgesetzblatt. In: [accessed 15.01.2026]. Available at: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/109/VO.html?nn=55638

Nomenklatur für alle lebenden Organismen, geordnet nach deren strukturellen Eigenschaften, zu begründen. Die Pflanze, die in dieser Facharbeit behandelt wird, heißt *Cannabis sativa*, gehört zur Familie der *Hanfgewächse (Cannabaceae)* und wird zusätzlich noch in mehrere Phänotypen unterschieden. In der Natur ist *Cannabis sativa* eine einjährige Blühpflanze und stammt ursprünglich aus äquatorialen und subtropischen Regionen, hauptsächlich aus Zentralasien. Die Abmessungen der Pflanze variieren jeweils stark von Phänotyp, Standort, Bodenbeschaffenheit und Klima, typisch sind aber eine Höhe von 1 bis zu 4 Metern und eine Stammdicke von 1 bis 3 Zentimeter.[2]

Des Weiteren gehört *Cannabis sativa* überwiegend zu den zweihäusigen Arten, das heißt, sie liegt in einem männlichen und weiblichen Geschlecht vor, die ihre Blüten auf unterschiedliche Weise ausbilden. In seltenen Fällen kann es jedoch auch vorkommen, dass vereinzelte Pflanzen einhäusig ausgeprägt sind, heißt, dass Blüten der Pflanze sowohl männliche, als auch weibliche Eigenschaften aufweisen können.[3]

Cannabis sativa weist eine komplexe Zusammensetzung sekundärer Pflanzenstoffe auf. Vor allem die zahlreichen Cannabinoide und Terpene der Pflanze – Stoffe, die die Pflanze zum eigenen Schutz ausbildet – spielen für diese Arbeit eine wichtige Rolle. Im Vordergrund werden allerdings hauptsächlich die Cannabinoide Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) stehen, da diese maßgeblich für die psychoaktive Wirkung im Körper verantwortlich sind.[4]

Neurobiologische Wirkweise im Körper

Cannabis entfaltet seine Wirkung im menschlichen Körper vor allem über das Endocannabinoid-System, das eine zentrale Rolle bei der Regulation von Stimmung, Schmerzempfinden, Gedächtnis, Appetit, Stressreaktionen und Immunprozessen spielt. Dieses System besteht aus Cannabinoid-Rezeptoren,

---

[2] HOURFANE, Sohaib et al. A Comprehensive Review on Cannabis sativa Ethnobotany, Phytochemistry, Molecular Docking and Biological Activities. *Plants*. 2023, vol. 12, no. 6. DOI: 10.3390/plants12061245

[3] GHOSH, Dipayan et al. Monoecious *Cannabis sativa* L. discloses the organ-specific variation in glandular trichomes, cannabinoids content and antioxidant potential. *Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants*. 2023, vol. 35. DOI: 10.1016/j.jarmap.2023.100476

[4] IVERSEN, Leslie. Cannabis and the brain. *Brain*. 2003, vol. 126, no. 6. DOI: 10.1093/brain/awg143

körpereigenen Botenstoffen (Endocannabinoiden) sowie Enzymen, die deren Synthese und Abbau steuern. Besonders relevant sind dabei die Rezeptoren CB1 und CB2. CB1-Rezeptoren befinden sich vor allem im zentralen Nervensystem, CB2-Rezeptoren hingegen sitzen überwiegend auf Immunzellen.[5]
Eine neurobiologische Besonderheit des Endocannabinoid-Systems ist die sogenannte retrograde Signalübertragung. Einfach erklärt ist dieses System eine Umkehrung des herkömmlichen Ablaufs innerhalb einer Synapse. Eine Synapse besteht, vereinfacht beschrieben, aus drei Teilen. Der Präsynapse, die einen Neurotransmitter aussendet, dem synaptischen Spalt, den der Transmitter durchläuft und der Postsynapse, die dann das Signal empfängt. Bei der retrograden Signalübertragung wird dieses Prinzip jedoch umgedreht, sodass das Signal von der Postsynapse zur Präsynapse ausgeht. Dabei werden durch einen starken, äußeren Reiz in der Postsynapse eigene Endocannabinoide hergestellt, die dann zur Präsynapse zurückwandern. Dort angekommen dienen sie als Hemmstoff für klassische Neurotransmitter, wodurch die neuronale Aktivität gebremst wird.[6]
Der psychoaktive Hauptwirkstoff von Cannabis, Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), imitiert diesen natürlichen Mechanismus. THC bindet sich an die CB1-Rezeptoren auf der Präsynapse und hemmt, unabhängig vom tatsächlichen Bedarf, die Neurotransmitterfreisetzung. Besonders deutlich passiert dieser Prozess im Hippocampus, da hier besonders viele CB1-Rezeptoren sitzen. Dadurch werden während des Rausches Prozesse wie die Langzeitpotenzierung gestört – ein Prozess, der eine Grundlage für das Lernen und die Gedächtnisbildung ist – weswegen es während des Rausches oft zu Kurzzeitgedächtnisproblemen kommen kann.[7]
Auch der präfrontale Cortex, der für Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung und Wahrnehmungsverarbeitung zuständig ist, wird durch die veränderte Neurotransmitterfreisetzung beeinflusst. Dies führt zu veränderter Zeitwahrnehmung, veränderter Aufmerksamkeit und einer veränderten kognitiven Verarbeitung von Reizen. Des Weiteren wirkt THC unter anderem auch auf die

[5] IVERSEN, Leslie. *Cannabis and the brain*.
[6] A.a.O.
[7] A.a.O.

motorischen Zentren im Gehirn, wodurch es während des Rausches zu Koordinationsstörungen kommen kann.[8]

Für das Suchtpotenzial ist vor allem die Wirkung auf das Belohnungssystem relevant, denn es wird auch die Ausschüttung von Dopamin gesteigert. Das dadurch erzeugte Gefühl von Euphorie und Belohnung kann bei einer späteren psychischen Abhängigkeit eine entscheidende Rolle spielen.[9]

Neben THC spielt Cannabidiol (CBD) eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu THC wirkt CBD nicht direkt auf die CB1- oder CB2-Rezeptoren, sondern beeinflusst das Endocannabinoid-System indirekt, indem es Enzyme hemmt, die normalerweise Endocannabinoide abbauen. So wird die Wirkung dieser Endocannabinoide verlängert. Zusätzlich interagiert CBD mit Serotonin-Rezeptoren, wodurch es angstlösend und stimmungsstabilisierend wirken kann. Darüber hinaus besitzt CBD entzündungshemmende Effekte und kann auch bestimmte unerwünschte Wirkungen von THC abschwächen.[10]

Abseits der ganzen psychischen Wirkungen wirkt Cannabis aber auch schmerzlindernd. Das liegt daran, dass über die CB1-Rezeptoren die Weiterleitung von Schmerzreizen in Rückenmark und Gehirn gehemmt, und über die CB2-Rezeptoren entzündliche Prozesse im Gewebe reduziert werden.[11]

Bei regelmäßigem Konsum kommt es zu neuroadaptiven Prozessen, das heißt, dass der Körper sich anpasst. Im Fall von Cannabis äußert sich das durch eine Herunterregulierung der CB1-Rezeptoren, also ihre Anzahl und Empfindlichkeit abnehmen. Dadurch kommt es zu einer Toleranzentwicklung, weswegen immer höhere Dosen erforderlich sind, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Nach dem Absetzen können deshalb Schlafstörungen, Reizbarkeit und Unruhe auftreten, da das Endocannabinoid-System Zeit benötigt, um sich wieder zu normalisieren.[12]

---

[8] IVERSEN, Leslie. *Cannabis and the brain*.
[9] A.a.O.
[10] PERTWEE, R. G. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. *British Journal of Pharmacology*. 2008, vol. 153, no. 2. DOI: 10.1038/sj.bjp.0707442
[11] WALKER, J. Michael and Susan M. HUANG. Cannabinoid analgesia. *Pharmacology & Therapeutics*. 2002, vol. 95, no. 2. DOI: 10.1016/s0163-7258(02)00252-8
[12] HIRVONEN, J. et al. Reversible and regionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily cannabis smokers. *Molecular Psychiatry*. 2012, vol. 17, no. 6. DOI: 10.1038/mp.2011.82

2.2 Entwicklungspsychologischer Rahmen

Gehirnentwicklung

Das menschliche Gehirn ist bis in die Mitte der zwanziger Jahre noch nicht vollständig ausgereift. Besonders der präfrontale Cortex, der für Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung, Impulskontrolle und komplexes Denken zuständig ist, befindet sich in dieser Lebensphase noch in der Entwicklung. Wenn nun Jugendliche regelmäßig Cannabis konsumieren, kann das den Reifungsprozess dieses Systems stören.

Es konnte bereits gezeigt werden, dass Cannabis-Konsum im Jugendalter mit Veränderungen in der Hirnstruktur verbunden ist, wie etwa einer Ausdünnung der Großhirnrinde im Bereich des präfrontalen Cortexes. Zwar ist diese Ausdünnung im Jugendalter normal, jedoch verläuft dieser Prozess bei Cannabis-Konsum verstärkter ab, als normalerweise üblich. Weiter konnte auch gezeigt werden, dass diese Veränderungen umso deutlicher auftreten, wenn Konsum und Dosis zunehmen, was auf eine dosisabhängige Wirkung hindeutet.

Vor allem spielt hier auch das bereits genannte Endocannabinoid-System eine entscheidende Rolle, da dieses, gerade im Jugendalter, eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Stressbewältigung sowie Motivation spielt.[13]

3. Kurzfristige Folgen des Konsums im jungen Alter

3.1 Kognitive und motorische Effekte

Die vorhandene Studienlage zu den Folgen von Cannabiskonsum ist im Vergleich zu anderen Drogen, wie zum Beispiel Alkohol, zwar noch recht dünn, jedoch können schon jetzt einige Schlüsse gezogen werden.

Eine Studie der University of California konnte nachweisen, dass Jugendliche, die Cannabis konsumieren, in Konzentrationstests schlechter abschneiden als andere Gleichaltrige, die kein Cannabis konsumieren. Das Ergebnis dieser ABCD-Studie (Adolescent Brain Cognitive Development-Studie), lautet wie folgt:

> „Jugendliche, die Cannabis konsumiert hatten, zeigten niedrigere Werte in einem Test zum episodischen Gedächtnis. Ein höherer

[13] ALBAUGH, Matthew D. et al. Association of Cannabis Use During Adolescence With Neurodevelopment. *JAMA Psychiatry*. 2021, vol. 78, no. 9. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2021.1258

> Cannabiskonsum korrelierte mit schlechteren Leistungen in verbalen, inhibitorischen, Arbeitsgedächtnis- und episodischen Gedächtnisaufgaben.“[14]

Auch Studien, die sich mit kurzfristigen, motorischen Folgen des Konsums auseinandergesetzt haben, konnten schon einige Schlüsse ziehen. Eine Studie der University of Colorado aus dem Jahr 2021 konnte zeigen, dass die motorischen Fähigkeiten nach dem Konsum langsamer waren, als normalerweise üblich.

> „Die Armgeschwindigkeit verlangsamte sich unmittelbar nach dem Konsum von Cannabis-Konzentraten und blieb auch nach einer Stunde beeinträchtigt […]. Die Beingeschwindigkeit verlangsamte sich eine Stunde nach dem Konsum […] und das Gleichgewicht verschlechterte sich unmittelbar nach dem Konsum […], jedoch nicht eine Stunde danach.“[15]

Eine weitere Studie konnte neben den motorischen Einschränkungen zudem zeigen, dass die Reaktionszeit bis zu sechs Stunden nach dem Konsum eingeschränkt ist.[16]

Zwar wurden diese Studien nicht unter Jugendlichen durchgeführt, da die rechtliche und ethische Grundlage dafür schwierig ist, jedoch ist stark davon auszugehen, dass diese Effekte bei jugendlichen Konsumenten sogar verstärkt auftreten, da das Gehirn noch wesentlich empfindlicher auf diese äußeren Einflüsse reagiert.

3.2 Psychische Effekte

Der am häufigsten beobachtete psychische Effekt ist die Angststörung. In einer Studie aus dem Jahr 2023 von KEUNG, Man Yee et al., wurden 1135 Patienten untersucht, die sich mit einer cannabisbezogenen Überdosis in

---

[14] Übersetzt aus: WADE, Natasha E. et al. Cannabis use and neurocognitive performance at 13-14 Years-Old: Optimizing assessment with hair toxicology in the Adolescent brain cognitive development (ABCD) study. *Addictive Behaviors*. 2024, vol. 150. DOI: 10.1016/j.addbeh.2023.107930

[15] Übersetzt aus: HITCHCOCK, Leah N. et al. Acute Effects of Cannabis Concentrate on Motor Control and Speed: Smartphone-Based Mobile Assessment. *Frontiers in Psychiatry*. 2020, vol. 11. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.623672

[16] RAMAEKERS, Johannes G. et al. High-Potency Marijuana Impairs Executive Function and Inhibitory Motor Control. *Neuropsychopharmacology*. Nature Publishing Group, 2006, vol. 31, no. 10. DOI: 10.1038/sj.npp.1301068

einem Krankenhaus vorstellten. Bei 17,3% der Patienten konnte dabei eine eben solche Angststörung nachgewiesen werden. Von diesen berichteten 98,9% von schweren Angstzuständen, es konnten aber auch Panikattacken (13,3%), aggressives oder manisches Verhalten (9,2%), Zittern und Schwindel (9,2%), Kopfschmerzen (5,1%) bis hin zu Paranoia (5,1%), Depressionen (4,6%) und Suizidgedanken (3,1%) beobachtet werden.
Wichtig hierbei zu erwähnen ist jedoch, dass Mischkonsum mit anderen Drogen nicht auszuschließen gewesen sei, da diese 17,3% der Patienten häufiger eine Vorgeschichte von Mehrfachsubstanzmissbrauch aufwiesen.[17]

3.3 Soziale Auswirkungen

Cannabiskonsum kann sich unmittelbar auf schulische Leistungen sowie auf die Bewältigung alltäglicher Aufgaben auswirken. Unmittelbar nach dem Konsum können so verschiedene kognitive und motorische Einschränkungen auftreten, die den schulischen Alltag direkt beeinflussen. Eine Meta-Analyse aus insgesamt 63 Studien ergab, dass unter anderem Konzentrationsprobleme, eine verlangsamte Reaktionsfähigkeit sowie eine eingeschränkte Koordination zu den möglichen kurzfristigen Folgen zählen. Diese Defizite können dazu führen, dass Jugendliche dem Unterricht schlechter folgen, Inhalte schlechter verarbeiten und Aufgaben oft langsamer bearbeiten.
Infolgedessen beteiligen sich betroffene Jugendliche öfter inaktiver am Unterricht, melden sich weniger oder sind generell unaufmerksamer. Auch praktische Tätigkeiten, Gruppenarbeiten oder sportliche Aktivitäten können durch den Konsum erschwert sein, was dazu beitragen kann, dass Jugendliche geringere schulische Leistungen erzielen, selbst wenn sie die fachlichen Fähigkeiten grundsätzlich beherrschen.
Darüber hinaus beschränken sich die Auswirkungen nicht nur allgemein auf die Qualität der schulischen Mitarbeit, sondern können auch die generelle Teilnahme am schulischen Alltag beeinträchtigen. Dazu zählt unter anderem die kontinuierliche Aufmerksamkeit über mehrere Unterrichtsstunden

[17] KEUNG, Man Yee et al. Cannabis-Induced Anxiety Disorder in the Emergency Department. *Cureus*. vol. 15, no. 4. DOI: 10.7759/cureus.38158

hinweg, die aktive Einbindung in mündliche Mitarbeit, sowie die verlässliche Erledigung von Aufgaben.[18]

4. Langfristige Folgen des Konsums im jungen Alter

4.1 Neurobiologische Entwicklung

Wie bereits im Punkt Gehirnentwicklung gezeigt, ist das Gehirn bis in die Mitte der zwanziger Jahre noch nicht vollständig ausgereift und deswegen in diesem Alter besonders vulnerabel gegenüber Cannabis. Von außen zugeführtes THC kann so die Prozesse des Endocannabinoid-Systems stören, welches eine zentrale Rolle in der synaptischen Umstrukturierung in der Jugendphase spielt.[19]

Auch die beschleunigt ablaufende Ausdünnung des präfrontalen Cortexes durch Cannabiskonsum kann langfristig dazu führen, dass Beeinträchtigungen in Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutiven Funktionen im jungen Erwachsenenalter auftreten können. Es konnte auch gezeigt werden, dass der frühe Beginn des Konsums im Alter von 12-14 Jahren mit kognitiven Defiziten im jungen Erwachsenenalter einhergeht.[20]

4.2 Psychische Effekte und langfristige Gesundheit

Im Bereich der psychischen Gesundheit lassen sich langfristige Zusammenhänge aufzeigen. Sämtliche Punkte aus Kapitel 3.2 über kurzfristige psychische Effekte lassen sich so auf die langfristigen Folgen übertragen. Erwachsene, die im Jugendalter angefangen haben Cannabis zu konsumieren, haben ein erhöhtes Risiko für Angststörungen, depressive Symptome und eine insgesamt reduzierte psychische Stabilität. Am besten untersucht ist hier der Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und psychotischen Störungen,

---

[18] CHAN, Olsen et al. Cannabis Use During Adolescence and Young Adulthood and Academic Achievement: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Pediatrics*. 2024, vol. 178, no. 12. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2024.3674

[19] ALBAUGH, Matthew D. et al. *Association of Cannabis Use During Adolescence With Neurodevelopment*.

[20] PAIGE, Katie J. and Craig R. COLDER. Long-Term Effects of Early Adolescent Marijuana Use on Attentional and Inhibitory Control. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*. 2020, vol. 81, no. 2. DOI: 10.15288/jsad.2020.81.164

wobei gezeigt werden konnte, dass häufiger Konsum und hohe THC-Potenz das Risiko für eine solche erhöhen.[21]

Darauf scheinen vor allem Jugendliche zu reagieren, die genetisch oder familiär vorbelastet sind. So weist eine Studie darauf hin, dass früher Beginn und hohe Konsumfrequenz signifikante Faktoren für spätere psychotische Episoden darstellen. Zwar entwickeln die meisten Konsumierenden keine Psychose, doch verschiebt sich das Erkrankungsrisiko statistisch messbar nach oben.[22]

Ein weiterer Punkt ist außerdem, dass bei inhalativen Konsum chronische Atemwegsbeschwerden auftreten können, insbesondere, wenn Cannabis mit Tabak kombiniert wird.

4.3 Suchtentwicklung

Schon lange ist bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Cannabisabhängigkeit stärker ist, wenn man in der Jugend mit dem Konsum anfängt. So zeigte schon die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Jahr 2007, dass das Risiko für eine spätere Sucht für Betroffene unter 16 Jahren deutlich größer ist, als für die, die erst im Erwachsenenalter mit dem Konsum anfangen. Eine Cannabissucht kann sich sowohl psychisch, als auch körperlich äußern und ein Entzug kann Symptome wie innere Unruhe, Gereiztheit und Ängstlichkeit bis hin zu Depressionen hervorrufen.[23]

4.4 Soziale Auswirkungen

Soziale Auswirkungen zeigen sich vor allem in Bildung, Berufsverlauf und sozialer Integration. Studien belegen, dass regelmäßiger Cannabiskonsum im Jugendalter mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Schulabbrüche und geringeren Abschlussquoten verbunden ist. Zudem besteht ein Zusammenhang mit erhöhter Kriminalität und sozialer Abschottung, wobei diese Effekte

---

[21] KEUNG, Man Yee et al. *Cannabis-Induced Anxiety Disorder in the Emergency Department*.

[22] KIBURI, Sarah Kanana et al. Cannabis use in adolescence and risk of psychosis: Are there factors that moderate this relationship? A systematic review and meta-analysis. *Substance Abuse*. 2021, vol. 42, no. 4. DOI: 10.1080/08897077.2021.1876200

[23] JORDAN, Susanne *Der Cannabiskonsum von Jugendlichen als Herausforderung für die pädagogische Arbeit.* 2007, Seite 8

teilweise durch begleitende Risikofaktoren wie familiärer Belastung oder ökonomischer Benachteiligung verbunden sind.[24]

5. Erfahrungsberichte

Um die Ergebnisse der Vielzahl an Studien einordnen zu können, habe ich für die Facharbeit eine Umfrage erstellt und mit drei Personen gesprochen, die selber seit ihrer Jugendphase Cannabis konsumieren. Das Ziel der Umfrage war somit, die bereits angeführten der Studien besser einordnen zu können.

5.1 Durchführung

Die gestellten Fragen waren in mehrere Unterkategorien aufgeteilt, die jeweils einen der bereits behandelten Aspekte abdeckten. Die Fragen bezogen sich auf die Themen: Konsumverlauf und -muster, kognitive und schulische Entwicklung, psychische Gesundheit, soziales Verhalten und Beziehungen, körperliche Gesundheit, Kontrollverlust und Abhängigkeit sowie eine rückblickende Einschätzung mit Reflexion. Auf die meisten Fragen konnte jeweils mit „Ja“ oder „Nein“ geantwortet werden, wodurch Durch- und Ausführung vereinfacht wurden.

5.2 Ergebnisse

5.2.1 Konsumverlauf und -muster

Alle Befragten gaben an, dass sie jeweils etwa mit 16 Jahren das erste Mal Cannabis konsumiert hätten. Auch ähneln sich die Situationen, in welchen sie anfänglich konsumiert haben: Es wurde ausschließlich in der Freizeit, zum Beispiel auf Partys mit Freunden, konsumiert.

Ein einheitliches, folgendes Konsummuster ausfindig zu machen ist allerdings schwierig, da die Intensität des Konsums bei allen Befragten eher wellenförmig ablief/abläuft. Alle gaben an, dass sie Phasen durchlaufen haben, in welchen sie den Konsum über mehrere Wochen bis hin zu Monaten ganz eingestellt hätten. Die Frequenz, in welcher sie dann aber außerhalb dieser Phasen konsumiert haben, variiert stark und reicht von allen drei Monaten, bis hin zu täglich.

[24] CHAN, Olsen et al. *Cannabis Use During Adolescence and Young Adulthood and Academic Achievement*.

5.2.2 Schulische Entwicklung

Entgegen der Studienlage gaben alle Personen an, dass sie nach Beginn des Konsums keine Auffälligkeiten in der Schule gehabt hätten. Sie bemerkten keinen Abfall der eigenen Konzentration, die schulischen Leistungen veränderten sich nicht und keiner der Befragten hat seinen schulischen Weg abgebrochen. Noch auffälliger ist jedoch, dass zwei der drei Befragten angaben, dass ihnen das Lernen nach Beginn des Konsums einfacher gefallen sei, als noch vor Beginn des Konsums. Ob hier allerdings wirklich ein Kausalzusammenhang besteht, ist nur schwierig nachzuweisen.

5.2.3 Psychische Gesundheit

In den Berichten konnte kein Zusammenhang zwischen Antriebslosigkeit und Cannabiskonsum hergestellt werden, lediglich eine Person gab an, dass sie an solchen Umständen litt, jedoch konnte sie Cannabis als Ursache für diese entschieden ausschließen. Auch durchlief keine der befragten Personen durch reinen Cannabiskonsum Phasen von Angst, Niedergeschlagenheit oder depressiver Stimmung. Lediglich eine Person gab an, einmal unmittelbar nach dem Konsum solche Erscheinungen gehabt zu haben, jedoch geschah das unter dem zeitgleichen Einfluss von Alkohol. Des Weiteren konnte keine Person eine negative Veränderung im eigenen Selbstwertgefühl feststellen, eine gab sogar an, dass es sich mit Beginn des Konsums bei ihr verbessert hätte. Auf die Frage, ob Cannabis als Mittel zur Bewältigung emotionaler Probleme benutzt wurde, gab nur eine Person an, zeitweilig Cannabis zu solchen Zwecken genutzt zu haben, sie jedoch schnell wieder damit aufgehört habe.

5.2.4 Soziales Verhalten und Beziehungen

Keine der befragten Personen gab an, sich von nicht konsumierenden Personen zurückgezogen zu haben, jedoch gaben zwei der Befragten an, dass sich ihre Freundschaften definitiv verändert hätten. Eine Person gab auch an, dass sie sich stärker an konsumierende Freundesgruppen gebunden fühle als an Nichtkonsumierende. Wiederum alle Personen gaben an, dass sie aufgrund des Konsums schonmal in Konflikten mit Eltern, oder auch Lehrkräften standen.

5.2.5 Körperliche Gesundheit

Was die körperliche Gesundheit angeht, konnte keiner der Befragten einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und körperlichen Folgen feststellen. Weder der Schlaf-Wach-Rhythmus, noch Schlafprobleme, Müdigkeit oder der Appetit scheinen sich bei den Befragten durch den Cannabiskonsum verändert/etabliert zu haben. Lediglich bei der Ausdauer konnte eine Person angeben, dass diese mal besser gewesen sei, jedoch raucht diese Person auch nicht nur Cannabis, sondern auch Tabak.

5.2.6 Kontrollverlust und Abhängigkeit

In dieser Kategorie unterscheiden sich die Angaben zwischen den Personen wieder deutlicher: Zwei der Befragten gaben an, dass sie weder jemals das Gefühl hatten, die Kontrolle über ihren Konsum zu verlieren, noch das sie jemals unter Entzugserscheinungen litten, oder Cannabis eine zentrale Rolle in ihrem Alltag gespielt hätte. Die dritte Person gab jedoch an, dass sie kurzeitig das Gefühl gehabt hätte, die Kontrolle über ihren Konsum zu verlieren und auch, dass Cannabis kurzeitig eine zentrale Rolle in ihrem Alltag gespielt habe. Anhand dessen ist gut zu sehen, dass jede Person anders auf Drogen reagiert und jeder unterschiedlich schnell in eine Abhängigkeit abrutschen kann.

5.2.7 Rückblickende Einschätzung und Reflektion

In dieser letzten Kategorie sind die Antworten sehr individuell und daher nur schwer zusammenzufassen. Grundsätzlich sind sich alle Befragten noch unschlüssig, wie sie ihren frühen Konsum bewerten sollen, da er bisher keine schwerwiegenden Folgen hatte. Eine Person äußerte jedoch Respekt vor Cannabis aufgrund negativer Ersterfahrungen, und vermutet mögliche langfristige Folgen aufgrund zunehmender Regelmäßigkeit. Einig sind sich alle, dass sie bislang keine Fähigkeiten oder Chancen als beeinträchtigt sehen, Jugendlichen jedoch eher vom frühen Konsum abraten würden. Zudem wünschten sie sich mehr Aufklärung und eine Enttabuisierung, wobei eine Person aber vor einer möglichen kontraproduktiven Wirkung bestimmter Formate warnte.

6. Fazit

Anhand der theoretischen Grundlagen wird deutlich, dass Cannabis über das Endocannabinoid-System tief in die Mechanismen des Gehirns eingreift. Im Jugendalter ist dies besonders relevant, da sich das Gehirn, insbesondere der präfrontale Cortex, noch entwickelt. Statistische Zusammenhänge zeigen, dass früher Konsum mit späteren kognitiven Einschränkungen verbunden sein kann. Auch für die psychische Gesundheit gilt, dass, je früher der Einstieg, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Abhängigkeit, Angststörungen oder in seltenen Fällen psychotische Episoden. Zudem weist eine Studie auf mögliche langfristige soziale Folgen hin. Dem gegenüber stehen die Ergebnisse der Erfahrungsberichte. Die Befragten berichteten von stabilen schulischen Leistungen, keinen nachhaltigen psychischen Beeinträchtigungen und keinem sozialen Abstieg. Zwar gab es kurzfristige Kontrollverluste oder soziale Konflikte, schwerwiegende langfristige Folgen wurden jedoch nicht wahrgenommen. Alle reflektierten ihren Konsum zumindest phasenweise und reduzierten oder beendeten ihn zeitweise. Diese Gegenüberstellung verdeutlicht den Unterschied zwischen statistischer Risikowahrscheinlichkeit und individueller Erfahrung. Studien mit großen Stichproben zeigen steigende Risiken, jedoch keine zwangsläufigen Entwicklungen. Die Berichte machen deutlich, dass Schutzfaktoren wie stabile soziale Einbindung oder ein reflektierter Umgang eine Rolle spielen können. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass diese Berichte nur von drei Personen und daher nicht repräsentativ sind. Dass von keinen spürbaren Folgen berichtet wurde, schließt unterbewusste Effekte nicht aus. Gleichzeitig zeigt sich, dass Cannabiskonsum im Jugendalter nicht automatisch zu schwerwiegenden Entwicklungsstörungen führen muss. Auf die Frage, welche neurobiologischen, psychischen und sozialen Folgen der Konsum von Cannabis im Jugendalter haben kann, lässt sich nun damit antworten, dass der Konsum mit klar belegten Risiken verbunden ist. Gravierende Risiken sind spätere kognitive Einschränkungen wie Konzentrations- und Gedächtnisschwächen, wesentlich schwerwiegender sind jedoch die erhöhten Wahrscheinlichkeiten, an psychischen Krankheiten oder einer Sucht zu erkranken. Als Appell lässt sich so formulieren, dass es ratsam ist, mit dem Konsum von Cannabis bis ins Erwachsenenalter zu warten, um möglichen Spätfolgen vorzubeugen.

7. Literaturverzeichnis

ALBAUGH, Matthew D. et al. Association of Cannabis Use During Adolescence With Neurodevelopment. *JAMA Psychiatry*. 2021, vol. 78, no. 9, p. 1031. ISSN 2168-622X. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2021.1258

CHAN, Olsen et al. Cannabis Use During Adolescence and Young Adulthood and Academic Achievement: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Pediatrics*. 2024, vol. 178, no. 12, pp. 1280–1289. ISSN 2168-6203. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2024.3674

GHOSH, Dipayan et al. Monoecious *Cannabis sativa* L. discloses the organ-specific variation in glandular trichomes, cannabinoids content and antioxidant potential. *Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants*. 2023, vol. 35, p. 100476. ISSN 2214-7861. DOI: 10.1016/j.jarmap.2023.100476

HIRVONEN, J. et al. Reversible and regionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily cannabis smokers. *Molecular Psychiatry*. 2012, vol. 17, no. 6, pp. 642–649. ISSN 1476-5578. DOI: 10.1038/mp.2011.82

HITCHCOCK, Leah N. et al. Acute Effects of Cannabis Concentrate on Motor Control and Speed: Smartphone-Based Mobile Assessment. *Frontiers in Psychiatry*. 2020, vol. 11, p. 623672. ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.623672

HOURFANE, Sohaib et al. A Comprehensive Review on Cannabis sativa Ethnobotany, Phytochemistry, Molecular Docking and Biological Activities. *Plants*. 2023, vol. 12, no. 6, p. 1245. ISSN 2223-7747. DOI: 10.3390/plants12061245

IVERSEN, Leslie. Cannabis and the brain. *Brain*. 2003, vol. 126, no. 6, pp. 1252–1270. ISSN 1460-2156, 0006-8950. DOI: 10.1093/brain/awg143

JORDAN, Susanne *Der Cannabiskonsum von Jugendlichen als Herausforderung für die pädagogische Arbeit.* 2007, Seite 8 https://www.bioeg.de/fileadmin/user_upload/PDF/themenschwerpunkte/suchtpraevention/arbeitshilfe_cannabis--cd12916f996f28ec84dc2e9a92be61c9.pdf

KEUNG, Man Yee et al. Cannabis-Induced Anxiety Disorder in the Emergency Department. *Cureus*. vol. 15, no. 4, p. e38158. ISSN 2168-8184. DOI: 10.7759/cureus.38158

KIBURI, Sarah Kanana et al. Cannabis use in adolescence and risk of psychosis: Are there factors that moderate this relationship? A systematic review and meta-analysis. *Substance Abuse*. 2021, vol. 42, no. 4, pp. 527–542. ISSN 1547-0164. DOI: 10.1080/08897077.2021.1876200

PAIGE, Katie J. and Craig R. COLDER. Long-Term Effects of Early Adolescent Marijuana Use on Attentional and Inhibitory Control. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*. 2020, vol. 81, no. 2, pp. 164–172. ISSN 1937-1888. DOI: 10.15288/jsad.2020.81.164

PERTWEE, R. G. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. *British Journal of Pharmacology*. 2008, vol. 153, no. 2, pp. 199–215. ISSN 0007-1188. DOI: 10.1038/sj.bjp.0707442

RAMAEKERS, Johannes G. et al. High-Potency Marijuana Impairs Executive Function and Inhibitory Motor Control. *Neuropsychopharmacology*. Nature Publishing Group, 2006, vol. 31, no. 10, pp. 2296–2303. ISSN 1740-634X. DOI: 10.1038/sj.npp.1301068

WADE, Natasha E. et al. Cannabis use and neurocognitive performance at 13-14 Years-Old: Optimizing assessment with hair toxicology in the Adolescent brain cognitive development (ABCD) study. *Addictive Behaviors*. 2024, vol. 150, p. 107930. ISSN 1873-6327. DOI: 10.1016/j.addbeh.2023.107930

WALKER, J. Michael and Susan M. HUANG. Cannabinoid analgesia. *Pharmacology & Therapeutics*. 2002, vol. 95, no. 2, pp. 127–135. ISSN 0163-7258. DOI: 10.1016/s0163-7258(02)00252-8

Bundesgesetzblatt Teil I - Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften - Bundesgesetzblatt. In: [accessed 24.01.2026]. Available at: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/109/VO.html?nn=55638

Erfahrungsberichte

Fragen zum Konsumverlauf und -muster

In welchem Alter hast du das erste Mal Cannabis konsumiert?

Person 1	Person 2	Person 3
16	16	16

Wie alt bist du jetzt?

Person 1	Person 2	Person 3
21	20	18

Wie regelmäßig hast du Cannabis konsumiert?

Person 1	Person 2	Person 3
Mal täglich, mal wochenlang nicht	Alle drei Monate mal	Etwa einmal im Monat

Wie hoch schätzt du deine damals durchschnittliche Konsummenge pro Woche ein?

Person 1	Person 2	Person 3
1g	-	-

In welchen Situationen hast du hauptsächlich konsumiert (Freizeit, Stress, Schule, sozialer Druck)?

Person 1	Person 2	Person 3
Freizeit	Mit Freunden auf Partys	Auf Partys

Machst du das immer noch? Wenn ja, wie regelmäßig?

Person 1	Person 2	Person 3
Ungefähr alle zwei Wochen	Inzwischen alle zwei bis drei Wochen	Kommt stark drauf an, wie häufig irgendwo Feiern sind

Gab es Phasen, in denen du deinen Konsum reduziert, oder ganz eingestellt hast?

Person 1	Person 2	Person 3
Ja	Ja, mehrere Male: Einmal als Neujahresvorsatz oder auch als ich frisch meinen Führerschein hatte, habe da locker ein halbes Jahr nicht gekifft	Ja

Kognitive und schulisch-berufliche Entwicklung

Hast du während deiner Schulzeit Veränderungen in deiner Konzentrationsfähigkeit bemerkt?

Person 1	Person 2	Person 3
Nö	Nein	Nein

Ist dir das Lernen mit der Zeit schwerer gefallen?

Person 1	Person 2	Person 3
Nein, gefühlt einfacher geworden	Ne, eher einfacher	Nö

Haben sich deine schulischen Leistungen nach Beginn des Konsums verändert?

Person 1	Person 2	Person 3
Nö	Gleichbleibend	Unverändert

Hast du Schule, Ausbildung oder Studium unterbrochen oder abgebrochen? Wenn ja, aus welchen Gründen?

Person 1	Person 2	Person 3
Nein	Nein	Nein

Hast du heute das Gefühl, dass dein Konsum deine berufliche Entwicklung beeinflusst hat?

Person 1	Person 2	Person 3
Arbeite jetzt als Gärtner…	Ne	Nein

Psychische Gesundheit

Hast du während oder nach deiner Jugendphase häufiger unter Antriebslosigkeit oder Motivationsverlust gelitten?

Person 1	Person 2	Person 3
Nein	Ja, das war aber definitiv nicht cannabisbedingt	Nö

Gab es Phasen von Angst, Niedergeschlagenheit oder depressiver Stimmung?

Person 1	Person 2	Person 3
Einmal, nach der Mischung mit Alkohol	Nein	Nein

Hast du Veränderungen in deinem Selbstwertgefühl wahrgenommen?

Person 1	Person 2	Person 3
Nicht bewusst	Sogar eine Verbesserung	Nein

Hattest du den Eindruck, Cannabis zur Bewältigung emotionaler Probleme zu nutzen?

Person 1	Person 2	Person 3
Nein	Zeitweilig ja, hab aber zum Glück schnell damit aufhören können	Nie

Soziales Verhalten und Beziehungen

Haben sich deine Freundschaften durch den Konsum verändert?

Person 1	Person 2	Person 3
Ja, zum Positiven	Habe angefangen mehr Zeit mit anderen Leuten zu verbringen. Ob das sinnvoll ist, lässt sich bestreiten	Blieben unverändert

Hast du dich zeitweise von Familie oder nicht konsumierenden Freunden zurückgezogen?

Person 1	Person 2	Person 3
Nö	Ne	Nein

Gab es Konflikte mit Eltern, Lehrern oder anderen Bezugspersonen wegen des Konsums?

Person 1	Person 2	Person 3
Ja, mit Lehrern	Ja, mit meinen Eltern	Ja, mit Eltern

Fühltest du dich stärker an konsumierende Freundesgruppen gebunden?

Person 1	Person 2	Person 3
Nö	Schon, ja	Nein

Wie schätzt du heute deine sozialen Kompetenzen ein?

Person 1	Person 2	Person 3
Super	War zwischenzeitlich schwierig, hat sich aber durch den Beruf verbessert	Gut

Körperliche Gesundheit

Hast du körperliche Veränderungen bemerkt (Schlafprobleme, Müdigkeit, Appetitveränderungen)?

Person 1	Person 2	Person 3
Nein	Ne	Nein

Hat sich dein Schlaf-Wach-Rhythmus im Jugendalter verändert?

Person 1	Person 2	Person 3
Nein	Ne	Ja, lag aber am Handy

Hattest du Probleme mit körperlicher Leistungsfähigkeit oder Ausdauer?

Person 1	Person 2	Person 3
Finde mich für meine Verhältnisse immer noch sehr ausdauernd (Person ist Raucher)	Nö	Nein

Kontrollverlust und Abhängigkeit

Hattest du das Gefühl, die Kontrolle über deinen Konsum zu verlieren?

Person 1	Person 2	Person 3
Nein	Kurzzeitig ja	Nie

Hast du Entzugserscheinungen wahrgenommen (z. B. Reizbarkeit, Schlaflosigkeit)?

Person 1	Person 2	Person 3
Nö	Nein	Auch nicht

Hatte Cannabis zeitweise eine zentrale Rolle in deinem Alltag?

Person 1	Person 2	Person 3
Nein	Ja	Nein

Rückblickende Einschätzung und Reflexion

Wie bewertest du rückblickend deinen frühen Cannabiskonsum?

Person 1	Person 2	Person 3
Würd's keinem empfehlen, aber schlecht fand ich es auch nicht	Mit großem Respekt. Hatte beim ersten Mal unschöne Erfahrungen die erstmal abschreckend waren, durch die ich dann vorsichtiger an die Sache rangegangen bin	Weder positiv noch negativ, hatte noch keine merklichen Folgen

Glaubst du, dass der Konsum langfristige Auswirkungen auf dein Leben hatte?

Person 1	Person 2	Person 3
Kann ich noch nicht sagen	Ja, durch zunehmende Regelmäßigkeit	Bisher nicht

Gibt es Fähigkeiten oder Chancen, die du im Nachhinein als beeinträchtigt wahrnimmst?

Person 1	Person 2	Person 3
Nö	Ne	Nein

Würdest du heute Jugendlichen vom frühen Cannabiskonsum abraten?

Person 1	Person 2	Person 3
Ja	Ja, das aber einfach pauschal zu sagen ist etwas schwierig, da es sehr auf die Person drauf ankommt. Manche können mögliche Negativeffekte besser kompensieren als andere, wodurch diese auch schon im jungen Alter dafür „bereit" wären	Abraten auf jeden Fall, wäre schlussendlich nicht mein Problem

Was hättest du dir damals an Aufklärung oder Unterstützung gewünscht?

Person 1	Person 2	Person 3
Mehr generelle Aufklärung, aber man muss mit dem Format aufpassen, sonst könnte das eher anstiftend wirken	Hätte mir mehr Aufmerksamkeit über das Thema gewünscht	Einfach mehr Präsenz von dem Thema, quasi eine Enttabuisierung

GymnasiumWildeshausen

Name der/s Schülerin/s: _____

Titel der Arbeit: _____

_____

Name der Fachlehrerkraft: Hr. Pottebaum

Ausgabetermin des Themas: 08.01.2026

Abgabetermin der Arbeit: 19.02.2026

_____
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)

Die vorliegende Facharbeit wurde am _____ eingereicht.

Note: _____ / _____ Punkte

_____
Unterschrift der Fachlehrerin/ des Fachlehrers

GymnasiumWildeshausen

E R K L Ä R U N G

Ich versichere, dass ich die vorgelegte Seminarfacharbeit persönlich und unverfälscht verfasst, sämtliche hierfür zu Hilfe genommenen gedruckten sowie digitalen Quellen im Literatur- bzw. Quellenverzeichnis angegeben und die aus diesen Quellen stammenden Zitate oder Belegstellen für sinngemäß wiedergegebene Inhalte in meiner Seminarfacharbeit als solche kenntlich gemacht habe.

Wildeshausen, den 18.02.2026

(Ort) (Datum)

(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)